

Sujet 47 : Insuffisance surrénalienne aigue

- 1. Une insuffisance corticotrope peuvent être due à (*obj n°1*) :**
 - A. une surrénalectomie unilatérale d'un adénome sécrétant le cortisol
 - B. une apoplexie d'un adénome hypophysaire
 - C. un syndrome de Schmidt
 - D. une radiothérapie cervicale
 - E. une interruption de la tige pituitaire

- 2. Une ISA périphérique, peut être due à (*obj n°1*):**
 - A. une surrénalectomie unilatérale d'un adénome sécrétant l'aldostérone
 - B. l'arrêt d'une corticothérapie prolongée
 - C. une adrenoleucodystrophie
 - D. en présence de triade de Witaker
 - E. en présence de syndrome de Scheehan

- 3. Une insuffisance surrénalienne périphérique est due à (*obj n°1*) :**
 - A. Une destruction de plus de 90% de tissu surrénalien
 - B. A l'arrêt d'une corticothérapie prolongée
 - C. Un infiltrat lymphocytaire des surrénales
 - D. Une anomalie des facteurs de transcription impliqués dans la stéroïdogénèse
 - E. Une infiltration métastatique de la surrénale droite

- 4. Devant une IS périphérique avec déficit neurologique vous suspectez (*obj n°1*):**
 - A. Bloc en 11 B hydroxylase
 - B. L'adrénoleucodystrophie
 - C. Déficit en protéine Star
 - D. L'utilisation de kétoconazole
 - E. Bloc en 21 hydroxylase

- 5. Un déficit en hormones corticosurrénaliennes par anomalie de la stéroïdogénèse peut se voir en cas de : (*obj n°1*):**
 - A. Une prise de mitotane
 - B. Un déficit en protéine Star
 - C. Un Déficit en 11 hydroxylase
 - D. Une prise de kétoconazole

E. Adrénoleucodystrophie

6. Une insuffisance surrénalienne transitoire peut être en rapport avec (obj n°1) :

- A. Une chirurgie d'une maladie de Cushing
- B. Un lymphome surrénalien
- C. Une hémorragie bilatérale des surrénales
- D. L'arrêt d'une corticothérapie prolongée
- E. Un adénome surrénalien sécrétant le cortisol

7. Une insuffisance surrénalienne périphérique peut entraîner (obj n°3) :

- A. Un déficit en minéralocorticoïdes
- B. Un déficit en androgènes
- C. Une carence prolongée en ACTH
- D. Une augmentation de la CRH
- E. Déficit en glucocorticoïdes

10. Le déficit en cortisol en cas d'atteinte périphérique entraîne (obj n°3) :

- A. une hypoglycémie par diminution de la production du glycogène hépatique
- B. une fatigabilité musculaire par diminution du glycogène musculaire
- C. une hypotension par résistance aux amines vasoconstrictrices
- D. une anémie par diminution de l'érythropoïèse
- E. une hyponatrémie par sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique

11. Une insuffisance surrénalienne primaire peut entraîner un déficit en (obj n°3) :

- A. glucocorticoïdes
- B. minéralocorticoïdes
- C. androgènes
- D. adrénaline
- E. dopamine

12. Le bilan d'une insuffisance surrénalienne périphérique aiguë, peut montrer (obj n°4):

- A. Une hypokaliémie
- B. Une kaliurèse basse
- C. Une natriurèse élevée

- D. Une acidose métabolique
- E. Une hémococoncentration

13. La gravité du tableau clinique d'une ISA peut être suspectée devant (obj n°5):

- A. Une confusion
- B. Une forme douloureuse abdominale
- C. Une hyperthermie sans foyer infectieux
- D. Des crampes musculaires
- E. Une acidose hyperkaliémique

14. En faveur d'une ISA périphérique grave, le bilan peut montrer (obj n°5):

- A. Une hypoglycémie sévère
- B. Une hyponatrémie sévère
- C. Une hypokaliémie sévère
- D. Une alcalose métabolique sévère
- E. Une acidose hyperkaliémique

15. Une insuffisance surrénalienne aiguë d'origine périphérique se distingue d'une atteinte centrale par (obj n°6):

- A. La présence de mélanodermie
- B. La sévérité du tableau clinique
- C. Le déficit en minéralocorticoïdes associé
- D. La présence d'un déficit en catécholamines
- E. La présence d'hyperkaliémie

16. La maladie d'Addison, peut être secondaire à (obj n°6):

- A. Une tuberculose hypophysaire
- B. Une destruction de la surrénale par un processus auto-immun.
- C. Une hémochromatose
- D. Une infiltration lymphomateuse des surrénales
- E. Une sarcoïdose neurohypophysaire

17. La décompensation d'un addisonien sur le mode aigu peut être précipitée par la prescription de (obj n°9):

- A. Laxatifs

- B. Anti-inflammatoires non stéroïdiens
- C. Barbiturique
- D. Diurétiques
- E. Ostrogroprogestatif

18. La voie parentérale est indiquée chez une patiente suivie pour maladie d'Addison connue non décompensée en cas (obj n°9):

- A. D'accouchement
- B. D'intervention chirurgicale
- C. De vomissement
- D. De stress professionnel
- E. D'infection cutanée

19. La cause la plus fréquente d'une insuffisance corticotrope est (obj n°10):

- A. le syndrome de Sheehan
- B. radiothérapie cérébrale
- C. hypophysite
- D. arrêt d'une corticothérapie prolongée
- E. apoplexie d'un adénome hypophysaire

20. Une femme âgée de 28 ans, suivie pour maladie d'Addison, enceinte à 4 SA, pour éviter toute décompensation aigue, on conseillera de :

- A. Poursuivre le traitement par l'hydrocortisone pendant la grossesse
- B. Augmenter la dose d'hydrocortisone au premier trimestre en cas de vomissements
- C. Prescrire l'hydrocortisone par voie parentérale lors du travail
- D. Ajouter une supplémentation en Kcl pendant la grossesse
- E. Augmenter la dose de fludrocortisone dès le premier trimestre

Cas clinique 1

Mme N.S âgée de 45 ans, consulte aux urgences pour des vomissements et des douleurs abdominales diffuses apparus il y a 2 jours. Elle est suivie au service de maladies infectieuses pour une infection VIH au stade SIDA sous traitement antirétroviral et kétoconazole pour une infection fongique. Elle est anorexique et a perdu 5 kg en 2 mois. A l'examen, sa PA est à 90/50 mm Hg, l'abdomen est souple, présence de mélanodermie et des lésions cutanées en rapport avec un sarcome de Kaposi. A la biologie, Natrémie à 125 mmol/l, kaliémie à 6 mmol/l, glycémie à 0,6 g/l, calcémie à 2,7 mmol/l, Hb à 10 g/dl et plaquettes à 30 000/mm³.

L'ECG est sans anomalies. Le diagnostic d'insuffisance surrénalienne aigue a été suspecté chez cette patiente.

21. Une insuffisance surrénalienne aigue est évoquée cliniquement devant :

- A. une anorexie
- B. des troubles digestifs
- C. une hypotension artérielle
- D. une mélanodermie
- E. un amaigrissement

22. A la biologie, une insuffisance surrénalienne aigue est évoquée devant :

- A. l'hypoglycémie
- B. l'hyperkaliémie
- C. la thrombopénie
- D. l'hyponatrémie
- E. l'hypercalcémie

23. Chez cette patiente, l'insuffisance surrénalienne peut être en rapport avec une cause:

- A. Autoimmune
- B. Infectieuse
- C. Vasculaire
- D. Tumorale
- E. Iatrogène

24. Que faut-il faire en urgence pour cette patiente?

- A. Prélèvement du cortisol en urgence
- B. Séance d'hémodialyse devant l'hyperkaliémie
- C. Administration de sérum glucosé à 5%
- D. Prescription de l'hydrocortisone 15-25 mg/j
- E. Prescription du fludrocortisone 100 µg/j

Cas clinique 2 :

Mme S. A âgé de 28 ans est hospitalisée pour suspicion d'une insuffisance surrénalienne aigue. Sa sœur est suivie pour maladie de Basedow. Elle se plaint d'asthénie, d'anorexie et d'amaigrissement depuis 3 mois. Elle rapporte l'installation depuis 2 jours des vomissements et des douleurs abdominales. A l'examen, sa pression artérielle est à 80/40 mm Hg, elle présente une mélanodermie et un goitre. Le bilan biologique montre une natrémie à 128mmol/l, kaliémie à 5,8mmol/l, urée à 15 mmol/l, créatinine à 138 µmol/l, TSH à 25mUI/l et anticorps antithyroperoxydase positifs. Une TDM abdominale a montré une atrophie surrénalienne. La cortisolémie faite pendant l'épisode aigu était à 75 ng/ml.

25. En faveur de l'origine périphérique de l'insuffisance surrénalienne, on retient :

- A. l'hyponatriémie
- B. l'insuffisance rénale fonctionnelle
- C. l'hyperkaliémie
- D. la mélanodermie
- E. l'amaigrissement

26. En faveur de l'étiologie auto-immune de la maladie d'Addison, on retient :

- A. le sexe féminin
- B. l'association à une thyroïdite de Hashimoto
- C. le terrain familial d'auto immunité
- D. l'hyperkaliémie
- E. l'atrophie surrénalienne à la tomodesitométrie

27. Afin de confirmer le diagnostic de l'insuffisance surrénalienne périphérique, il faut :

- A. Refaire le dosage de la cortisolémie
- B. Faire le dosage du cortisol libre urinaire
- C. Faire le dosage de l'aldostérone et de la rénine
- D. Faire un test au Synacthène à distance
- E. Faire le dosage de l'ACTH

28. A distance de l'épisode aigu, le traitement chez ce patient repose sur :

- A. Hydrocortisone 20 mg/j par voie orale
- B. L-thyroxine avant l'introduction de l'hydrocortisone
- C. Fludrocortisone 50 µg/j le matin
- D. Adjonction du KCl
- E. Régime pauvre en sel

Cas clinique 3 :

Mme M. R âgée de 34 ans, consulte pour prise pondérale et apparition de vergetures pourpres au niveau de l'abdomen et des racines des membres. Elle est suivie de façon irrégulière pour LES sous prednisone : 20 mg le matin et 20 mg le soir depuis 6 mois. Devant l'amélioration de sa symptomatologie, son médecin lui a indiqué l'arrêt progressif de la prednisone puis le relais par l'hydrocortisone.

29. Le risque d'insuffisance surrénalienne après l'arrêt de la corticothérapie est accru chez cette patiente à cause de :

- A. La durée prolongée de la corticothérapie
- B. L'arrêt progressif de la corticothérapie
- C. Le switch vers l'hydrocortisone
- D. Le syndrome de Cushing iatrogène
- E. La prise nocturne de la corticothérapie

30. La dose de prednisone minimale qui permet d'éviter le risque d'insuffisance corticotrope lors de la dégression est :

- A. 2,5 mg
- B. 5 mg
- C. 10 mg
- D. 15 mg
- E. 20 mg

31. L'hydrocortisone peut être arrêtée chez cette patiente si :

- A. La cortisolémie à 8h est à 65 ng/ml
- B. La cortisolémie à 8h est à 120 ng/ml
- C. La cortisolémie à 8h est à 185ng/ml
- D. Cortisolémie après un test au Synacthène à 130 ng/ml
- E. Cortisolémie après un test au Synacthène à 200 ng/ml

32. Si le bilan hormonal confirme l'insuffisance corticotrope chez cette patiente, il faut :

- A. Recontrôler ce bilan à distance
- B. Doubler la dose d'hydrocortisone en cas de stress
- C. Limiter les apports hydriques journaliers
- D. Eviter le jeûne du mois de Ramadan
- E. Eviter la vaccination anti grippale

Cas clinique 4 :

Un patient âgé de 22 ans, suivi pour diabète de type 1, habituellement bien équilibrée sous analogues d'insuline. Depuis quelques mois, il se plaint d'une asthénie, d'un amaigrissement inexpliqué avec des hypoglycémies à répétition, malgré la réduction des doses d'insuline. Après un match de foot, il a présenté des nausées et des douleurs abdominales avec aggravation de son tableau clinique nécessitant son hospitalisation en urgence. À l'arrivée à l'hôpital, il a présente un coma agité. La glycémie capillaire est à 0,30 g/L. L'examen clinique retrouve une déshydratation et une mélanodermie. L'ionogramme sanguin retrouve une natrémie à 119 mmol/L, avec kaliémie à 6,1 mmol/L, glycémie veineuse à 0,34 g/L

33. Vous suspectez une insuffisance surrénalienne aigue devant :

- A. L'hypoglycémie à répétition
- B. L'amaigrissement
- C. Les douleurs abdominales
- D. La déshydratation
- E. L'ancienneté du diabète depuis 10 ans

34. Quelle serait l'étiologie la plus probable de cette insuffisance surrénalienne ?

- A. Tuberculose surrénalienne
- B. Auto-immune
- C. Insuffisance corticotrope
- D. Métastases surrénaliennes bilatérales
- E. Hypophysite

35. On demandera en urgence le dosage de :

- A. Dosage de cortisol
- B. Dosage d'ACTH
- C. Test de Synacthène®
- D. Test d'hypoglycémie insulinique
- E. Dosage d'aldostérone

36. Quel serait votre conduite en urgence ?

- A. Perfusion de sérum glucosé
- B. Supplémentation en NaCl
- C. Supplémentation en KCl
- D. Hémissuccinate d'hydrocortisone en IV
- E. Arrêt définitif de l'insuline

37. Après amélioration clinique, le traitement reposera sur :

- A. L'hydrocortisone
- B. La prédnisone
- C. La dexaméthasone
- D. Le fluorocortisone
- E. Un régime normosodé

Cas clinique 5 :

Une patiente de 45 ans consulte aux urgences pour douleurs abdominales et vomissements depuis 24h. Elle se plaint également de brûlures à la miction depuis 4 jours. Elle a constaté aussi un amaigrissement de 15 kg en 6 mois avec asthénie importante et une hyperpigmentation récente. L'examen clinique objective une température à 38,5 °, TA à 80/60 mmHg et une fréquence cardiaque à 120 bat/min. Elle présente des douleurs lombaires droites. Le bilan montre: NFS : Hb11g/dl, VGM89, Ht51%, GB20000/mm³, Na⁺122mmol/L, K⁺6.1mmol/L, créatinine : 151μmol/l, urée 18μmol/l, glycémie : 0,5g/l, Bandelette urinaire : Leucocyte+++ Nitrite++/ AUSP : calcifications en regard de D12 L1.

Vous évoquez une décompensation surrénalienne aiguë d'une insuffisance surrénalienne lente.

38. Pour confirmer le diagnostic positif de l'insuffisance surrénalienne aiguë, vous demandez le dosage en urgence de :

- A. Cortisol plasmatique après un test au Synacthène
- B. 17 OH progestérone
- C. Cortisol plasmatique
- D. Aldostérone
- E. Cortisol libre urinaire sur échantillon

39. En faveur de l'atteinte périphérique de l'insuffisance surrénalienne aiguë chez ce patient, on retient :

- A. L'hyperpigmentation
- B. L'hyponatrémie
- C. L'hyperkaliémie
- D. L'hypoglycémie
- E. L'insuffisance rénale fonctionnelle

40. L'étiologie de cette insuffisance surrénalienne est

- A. Auto-immune
- B. Bloc enzymatique
- C. Tuberculose surrénalienne
- D. Métastases surrénaliennes
- E. Syndrome de Sheehan

41. La prise en charge en urgence de cette patiente repose sur :

- A. Sérum glucosé par voie veineuse associé à du sérum salé isotonique
- B. Supplémentation potassique
- C. Remplissage vasculaire par des macromolécules
- D. Hydrocortisone par voie orale
- E. Antibiothérapie adaptée

Cas clinique 6 :

Un patient de 20 ans consulte les urgences pour douleurs abdominales avec diarrhée, vomissements, myalgies, fatigue importante et une fièvre à 38.5 °c. Ce tableau clinique évolue depuis 24 heures. Sa Sœur est suivie pour hypothyroïdie. L'examen clinique trouve une tachycardie à 110/min, TA à 8/6 cm Hg, pli cutané, abdomen souple, on ne lui trouve pas de raideur méningée, des taches ardoisées au niveau de la face interne des joues et des gencives sont constatées.

Il présente une anorexie depuis 4 mois et a perdu 6 kg.

Le bilan biologique montre une natrémie à 127 mmol/L, une kaliémie à 6,1 mmol/L et une glycémie à 0,55g/L, la TSH : 25 mUI/l (VN : 0,45-4,5). La Radio thorax : séquelles de tuberculose au niveau du lobe supérieur gauche.

Le tableau est compatible avec une décompensation aigue d'une insuffisance surrénalienne lente

42. En faveur de l'atteinte périphérique de l'insuffisance surrénalienne aigue chez ce patient, on retient :

- A. Les taches ardoisées
- B. L'hyponatrémie
- C. L'hyperkaliémie
- D. L'hypoglycémie
- E. Les myalgies

43. Pour confirmer le diagnostic positif de l'insuffisance surrénalienne aigue, vous demandez le dosage en urgence de :

- A. ACTH
- B. 17 OH progestérone

- C. Cortisol plasmatique
- D. Aldostérone
- E. Cortisol libre sur échantillon

44. A la recherche de l'étiologie de cette insuffisance surrénalienne aiguë, vous

- A. Complétez l'interrogatoire pour préciser les antécédents familiaux et personnels
- B. Demandez une TDM abdominale
- C. Demandez une recherche de BK dans les crachats
- D. Doser les anticorps anti 21 hydroxylase
- E. Réalisez un test au Synacthène

45. Le bilan étiologique est en faveur de tuberculose encore active. Après avoir jugulé le cap aigu, la prescription à la sortie doit comporter :

- A. La dexaméthasone
- B. La L thyroxine
- C. L'hydrocortisone
- D. Antituberculeux incluant la Rifampicine
- E. 9 alphafluorocortisone

46. En prescrivant le traitement à ce patient, il faut :

- A. Commencer L-thyroxine après avoir initié le traitement par l'hydrocortisone
- B. Augmenter la dose d'hydrocortisone habituelle prescrite
- C. Augmenter la dose de minéralocorticoïde si le patient garde une hypotension
- D. Ajouter de la dexamétasone si le patient ne s'améliore pas
- E. Donner l'hydrocortisone en trois prises

Cas clinique n° 6 :

Mme D âgée de 32 ans se présente aux urgences pour douleurs abdominales et vomissements évoluant depuis 2 jours.

Elle rapporte une asthénie depuis 8 mois, qui s'est installée après son dernier accouchement qui était très hémorragique. Le traitement martial qui lui a été prescrit ne l'a pas améliorée et elle n'a pas allaité son enfant. A noter qu'elle est asthmatique sous traitement inhalé en cas de besoin. Elle est toujours en aménorrhée et a perdu 5 kg. L'examen trouve une TA 110/ 80 mm Hg, une pâleur généralisée. L'abdomen est souple.

Le bilan : NFS : Hb12g/dl, VGM 85, Ht49%, GB 9000/mm³, Na⁺135mmol/L, K⁺4,3 mmol/l, créatinine : 96μmol/l, urée 10μmol/l, glycémie : 0,45g/l. L'échographie abdominale est normale. Vous suspectez une ISA.

43. Cette insuffisance surrénalienne aiguë pourrait être en rapport avec :

- A. une hypophysite
- B. un adénome hypophysaire
- C. un syndrome de Sheehan
- D. une maladie d'Addison
- E. l'arrêt d'une corticothérapie

44. En faveur de l'atteinte surrénalienne centrale on retient :

- A. pâleur généralisée
- B. aménorrhée
- C. absence d'allaitement
- D. L'hypotension artérielle.
- E. Douleurs abdominales

45. Que faut-il demander en urgence pour confirmer le diagnostic chez cette patiente ?

- A. Cortisol plasmatique
- B. Cortisol libre urinaire
- C. Aldostérone
- D. Test au Synacthène
- E. Test hypoglycémie insulinique

46. La prise en charge en urgence comporte :

- A. Perfusion de sérum glucosé à 5% en IV
- B. Supplémentation potassique en IV
- C. Remplissage vasculaire
- D. Bolus d'hémisuccinate d'hydrocortisone

E. Injection de minéralocorticoïdes

47. Une fois l'urgence traitée, cette patiente doit :

- A. Doubler la dose d'hydrocortisone en situation de stress
- B. suivre un régime sans sel
- C. doubler la dose de minéralocorticoïdes
- D. injecter de l'hémisuccinate d'hydrocortisone en cas de diarrhée
- E. Avoir une carte d'addisonien